BKEOK - LMO
3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11
Telefon: 555-666

LABORATÓRIUMI LELET

Laboratóriumi Medicina Osztály II.
Labor vezető: Dr. Kállai Tibor

Páciens neve: Horváth Jázmin
Taj-száma: 125 739 947
Születési dátum: 2009. 11. 08.
Lakcím: 3530 Miskolc, Tompa Mihály utca 24

Nem: Nő

Napi sorszám: 12

Beutaló orvos: 25331

Beutaló egység: 4124536134 Toxikológia

Dátum: 2026. 04. 24.

Azon.: 0104425392

K L I N I K A I K É M I A É S H E M A T O L Ó G I A

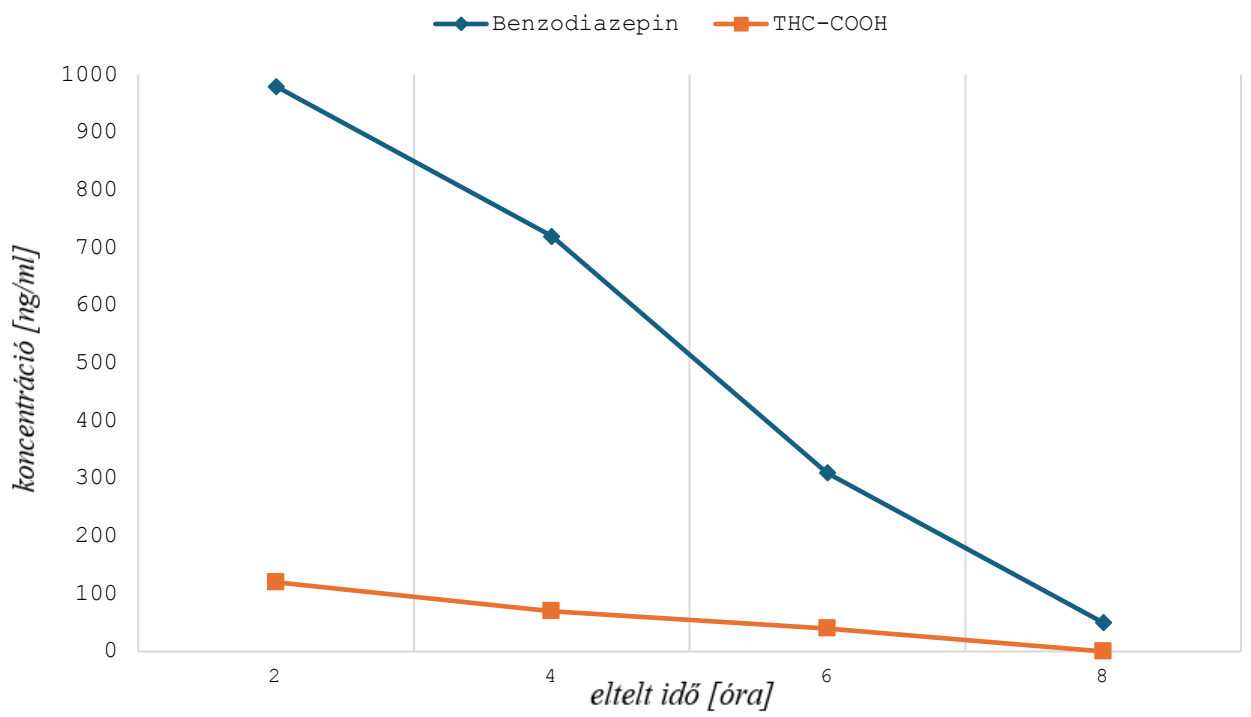
Kért vizsgálatok:	Eredmény:	mértékegység	Referencia érték:
WBC (Fehérvérsejt)	8,9	G/L	4,0 - 10,0
RBC (Vörösvérsejt)	4,8	T/L	4,5 - 5,9
Hemoglobin	150	g/L	135 - 175
Hematokrit	0,44	L/L	0,40 - 0,52
PLT (Trombocita)	190	G/L	150 - 400
Vércukor (éhomi)	5,9	mmol/l	3,6 - 6,0
Nátrium	138	mmol/l	136 - 145
Kálium	4,1	mmol/l	3,5 - 5,1
Kreatin-kináz (CK)	210	U/L	40 - 190 (H)
S-Etanol (Véralkohol)	1,35	g/l	< 0,20 (Pozitív)
CRP (Gyulladásos marker)	3,1	mg/l	0,0 - 5,0

BKEOK - LMO 3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11 Telefon: 555-666	**LABORATÓRIUMI LELET**	Laboratóriumi Medicina Osztály II. Labor vezető: Dr. Kállai Tibor

SÜRGŐSSÉGI TOXIKOLÓGIAI PANEL

A szűrés immunkémiai módszerrel történt

Kért vizsgálatok:	Eredmény: Mértékegység	Határérték
Amphetamine	< 50 ng/ml	500 ng/ml
MDMA	< 50 ng/ml	500 ng/ml
THC-COOH	120 ng/ml	50 ng/ml
Benzodiazepin	980 ng/ml	200 ng/ml
Cocaine Metabolite	< 50 ng/ml	300 ng/ml
Opioidok	< 100 ng/ml	2000 ng/ml
Methadone	< 25 ng/ml	300 ng/ml



ORVOSI SZAKVÉLEMÉNY ÉS ÉRTÉKELÉS

A rendelkezésre álló laboratóriumi eredmények és a klinikai megfigyelések alapján a páciens állapota egyértelműen akut, kevert depresszáns hatású intoxikációnak felel meg. A vérben kimutatott jelentős mennyiségű benzodiazepin, feltehetően alprazolam, valamint a magas etanolszint együttesen súlyos központi idegrendszeri depressziót idéz elő. A két szer farmakodinámiás szinergizmusa következtében fokozott a légzőközpont gátlása, amely klinikailag aluszékonyságban, csökkent reakciókészségben, valamint potenciálisan életveszélyes légzésdepresszióban nyilvánulhat meg. A jelenlegi laborparaméterek ugyan nem utalnak súlyos szervkárosodásra, azonban a klinikai állapot gyors romlása bármikor bekövetkezhet.

Külön kiemelendő, hogy a hasonló típusú szerhasználat gyakran társul tudatzavarral és aspirációs kockázattal, ami másodlagos szövődmények (pl. aspirációs pneumonia) kialakulásához vezethet. A páciens állapota emiatt folyamatos megfigyelést igényel, mivel a tünetek hullámzó intenzitással jelentkezhetnek, és a felszívódás elhúzódása miatt késleltetett romlás sem zárható ki.

Diagnózis:

- **F13.1**
- **F10.0**

Javaslat és további teendők:

A beteg ellátása során elsődleges a légzés és a keringés stabilitásának folyamatos monitorozása, különös tekintettel a légzésszám és az oxigénszaturáció alakulására. Indokolt az intenzív megfigyelő környezet biztosítása, ahol szükség esetén azonnali légútbiztosítás és gépi lélegeztetés megkezdhető. A benzodiazepin hatás felfüggesztésére szolgáló antidotum alkalmazása (flumazenil) csak szigorú mérlegelés mellett javasolt, tekintettel az esetleges megvonásos görcsök kockázatára.

Emellett javasolt intravénás folyadékpótlás, valamint a tudatállapot rendszeres neurológiai ellenőrzése. A beteg stabilizálódását követően elengedhetetlen addiktológiai és pszichiátriai konzílium, mivel a kombinált szerhasználat jelentős visszaesési és ismételt intoxikációs kockázattal jár.

…….

Kelt: Miskolc, 2026. 04. 24.

Az ellátásért felelős orvos